

## 1 胃癌の薬薬連携 — S-1・胃切除後・新しい標的薬

| 病院薬剤師                                | 病院と共有する情報                      | 保険薬局薬剤師                       |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| ① HER2・CLDN18.2・PD-L1の結果とレジメンの整合性の監査 | HER2・CLDN18.2・PD-L1<br>(治療の選択) | ① S-1・カペシタビンの服用日・休業日と残薬の管理    |
| ② シスプラチンの補液・Mg補充、制吐薬の設定              | 腎機能<br>(S-1の用量)                | ② 腎機能とS-1の用量、フッ化ピリミジン系の重複確認   |
| ③ ゾルベツキシマブ初回の投与速度・制吐薬強化の管理           | 食事量・体重<br>(胃切除後)               | ③ 電話フォローで悪心・下痢・発熱・食事量を確認      |
| ④ T-DXd・ニボルマブのILD・irAE発症時の院内連携       | 流涙・しびれ<br>(S-1・オキサリプラチン)       | ④ 胃切除後の食事・体重の変化を聴取し栄養指導へつなぐ   |
| ⑤ 胃切除の術式と術後の栄養状態を薬局へ伝達               |                                | ⑤ S-1の流涙・色素沈着、オキサリプラチンのしびれを聴取 |

## 2 主なレジメンと薬局での確認ポイント

|                             |                                    |     |                                       |
|-----------------------------|------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| <b>SOX / CAPOX</b><br>点滴+経口 | オキサリプラチン(1日目)+S-1またはカペシタビン1~14日目内服 | 3週毎 | ✓内服日数と休業 ✓寒冷刺激による急性しびれ ✓手足症候群(カペシタビン) |
| <b>S-1+シスプラチン</b><br>点滴+経口  | S-1 1~21日目内服+シスプラチン(8日目)           | 5週毎 | ✓シスプラチンの大量補液・腎機能 ✓高度催吐性の制吐薬           |
| <b>S-1単独(術後)</b><br>経口      | S-1 4週服用・2週休業を1年間                  | 6週毎 | ✓腎機能に応じた用量 ✓流涙・色素沈着 ✓アドヒアランス          |
| <b>RAM+PTX</b><br>点滴・注射     | ラムシルマブ(1・15日目)+パクリタキセル(1・8・15日目)   | 4週毎 | ✓高血圧・尿蛋白 ✓好中球減少 ✓末梢神経障害               |
| <b>ゾルベツキシマブ併用</b><br>点滴・注射  | ゾルベツキシマブ+CAPOX/SOX 等               | 3週毎 | ✓初回の悪心・嘔吐(制吐薬の強化) ✓体重・食事量             |
| <b>T-DXd</b><br>点滴・注射       | 点滴(HER2陽性、化学療法後)                   | 3週毎 | ✓咳・息切れ・発熱(ILD) ✓悪心・嘔吐 ✓骨髄抑制           |

● 経口 ● 点滴・注射 ● 点滴+経口 経口薬は保険薬局で交付:服用日・休業日と自宅での副作用を確認

## 3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サブリを含む)

| 重要度                        | 薬剤(機序)                         | 相手の薬(区分)                                | 起こること                | 薬局での対応                |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>禁忌</b><br>添付文書<br>併用禁忌  | S-1<br><b>DPD阻害(ギメラシル)</b>     | <b>処方薬</b><br>他のフッ化ピリミジン系(カペシタビン・5-FU等) | 5-FU濃度↑ → 重篤な骨髄抑制・下痢 | 切り替え時は7日以上空ける         |
| <b>注意</b><br>添付文書<br>併用注意  | S-1・カペシタビン<br><b>CYP2C9の抑制</b> | <b>処方薬</b><br>ワルファリン・フェニトイン             | INR↑(出血)・フェニトイン中毒    | INR測定を処方医と確認          |
| <b>注意</b><br>添付文書<br>用法・用量 | S-1<br><b>ギメラシルの排泄低下</b>       | <b>既往・疾患</b><br>腎機能の低下                  | 5-FU濃度↑ → 骨髄抑制・下痢    | CCrに応じた用量が確認          |
| <b>注意</b><br>添付文書<br>用法・用量 | FTD/TPI<br><b>空腹時は吸収が増加</b>    | <b>生活習慣</b><br>空腹時の服用                   | 好中球減少が増強             | 朝・夕の食後に服用するよう指導       |
| <b>確認</b><br>服薬指導上の<br>注意  | S-1<br>症状を隠す                   | <b>市販薬</b><br>市販の胃腸薬・下痢止め               | 下痢・脱水の見逃し            | 市販薬の使用を聴取し、まず連絡するよう指導 |

## 4 服薬指導タイムライン — 胃癌の治療に合わせて

| ① 治療開始前                                             | ② 投与当日~5日                                    | ③ 術後補助療法(S-1 1年)                                | ④ 次回来局時                               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| “S-1は2週飲んで1週休むなど、決まった日程で飲みます。休業日もカレンダーと一緒に確認しましょう”  | “吐き気止めは、吐き気がなくても決められた時間に飲んでください。水分は少しずつこまめに” | “術後のS-1は1年間続けることで再発を防ぎます。食事がとれない時は我慢せず相談してください” | “涙が出やすい、手足がしびれる、咳や息切れが続くなどの変化はありませんか” |
| ✓薬局で確認<br>お薬手帳でHER2・CLDN18.2・PD-L1、腎機能(S-1の用量)、胃切除歴 | ✓薬局で確認<br>電話フォローで悪心・水分量・尿量(シスプラチン後)を確認       | ✓薬局で確認<br>食事量・体重、S-1の服用日と残薬                     | ✓薬局で確認<br>流涙・色素沈着、しびれのGrade、体重、咳・息切れ  |
| △ここに注意<br>他のフッ化ピリミジン系・ワルファリンとの併用を確認                 | △ここに注意<br>水分がとれない・尿が少ない時は至急連絡                | △ここに注意<br>食事がとれず脱水傾向の時は継続を処方医と相談                | △ここに注意<br>咳・息切れ・発熱はILDを疑い早めに受診        |